Verwijzing voetzorg

Geachte pedicure,podotherapeut

Graag verwijs ik naar u de volgende patiënt:

Naam patiënt: _____ M / V

Adres: _____ Woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____ Geboortedatum: _____

Verzekeringsgegevens: _____ Datum verwijzing: _____

BSN nummer: _____

Simms klasse	**Zorgprofielen / ZP**
☐ Simms 0	
☐ Simms 1, in staat tot zelfmanagement	0 ZP 1
☐ Simms 1, niet in staat tot zelfmanagement	0 ZP 2*
☐ Simms 2	0 ZP 2 / 0 ZP 3*
☐ Simms 3	0 ZP 3 / 0 ZP 4*

Reden niet in staat tot zelfmanagement

- ☐ Cognitieve beperkingen (beperking van geheugen of begripsvorming)
- ☐ Visusklachten
- ☐ Alleenstaande risicodrager (bijvoorbeeld alleenstaande ouderen met onvoldoende ziekte inzicht
- ☐ Adipositas
- ☐ Bewegingsbeperkingen (stijfheid of overige fysieke beperking)

***Vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten / infectie** **Simms 1 wordt zorgprofiel 2**

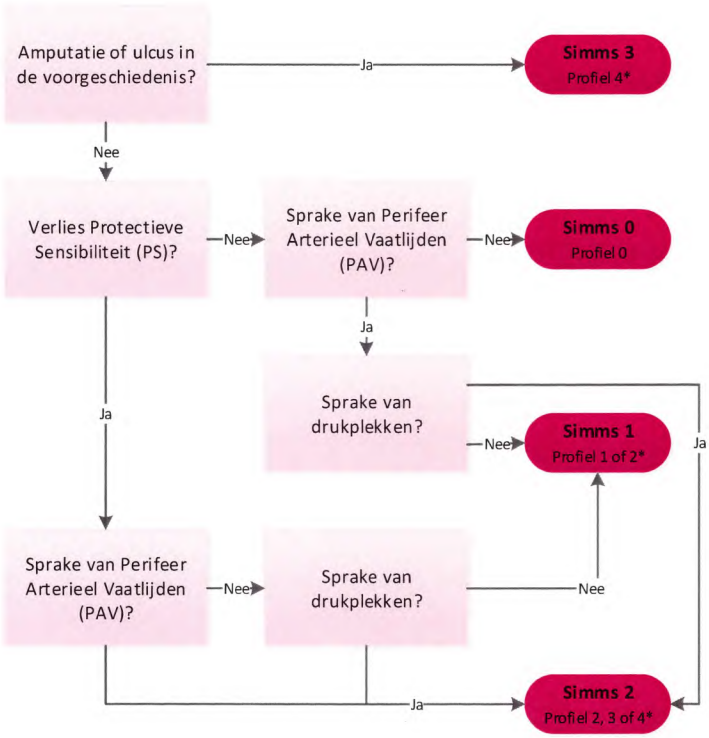
- ☐ PAV en loopafstand < 100 meter
- ☐ MDRD < 30 ml / min
- ☐ Gebruik immunosuppressiva
- ☐ Chronisch prednisongebruik
- ☐ Chemotherapie
- ☐ LJM = Limited Joint Mobility

***Vastgesteld verhoogd risico op drukplekken** **Simms 2 wordt zorgprofiel 3**

- ☐ Voetdeformiteit tw :
  - Standafwijking
  - Orthopedisch schoeisel

Met vriendelijke groet,

Samenvattingskaart voetonderzoek



PS

Onderzoek met monofilament (10 gram).
Doe een voeltest ter hoogte van de elleboog. Zet monofilament loodrecht op de drie aangegeven plekken (zie tekening), laat patiënt de ogen sluiten, nooit op een eeltplek testen en doe altijd een dummy.
Per locatie 3x testen.
Bij meer dan één niet-voelbare plek is sprake van PS.

PAV

Beluister vaattonen → bi- en trifasisch is normaal
→ monofasisch is afwijkend

Eventueel bepaling Enkel Arm Index (EAI).
- < 0,5 : Kritische ischaemie, doorsturen vaatchirurg
- < 0,9 (gemiddelde 3 metingen) : PAV aangetoond
- 0,9 – 1,15 : Normale bevinding
- > 1,15 (gemiddelde 3 metingen) : Bij DM onbetrouwbaar, denk aan mediasclerose (Monckeberg fenomeen)

Drukplekken

Eeltvorming op met name vreemde plaatsen kan een indicator zijn voor verhoogde druk en schuifkrachten.

Let op de anatomie van de voeten (klauwstand tenen, platvoet, holvoet).

NB. Ben bedacht op Limited Joint Mobility.

Zorgprofielen*

Zorgprofiel 0 :	- Geen verlies PS of PAV - Diabetes en niet in staat tot zelfmanagement
Zorgprofiel 1 :	- Verlies PS <u>óf</u> PAV
Zorgprofiel 2 :	- Verlies PS <u>óf</u> PAV met vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten / infectie - Verlies PS <u>óf</u> PAV met vastgesteld verhoogd risico op drukplekken - Verlies PS <u>én</u> PAV
Zorgprofiel 3 :	- Verlies PS <u>óf</u> PAV met drukplekken - Verlies PS <u>én</u> PAV met drukplekken
Zorgprofiel 4 :	- Genezen of actief ulcus - Amputatie

Zelfmanagement

Of een patiënt wel of niet in staat is tot zelfmanagement, is niet langer van invloed op de inschaling van het zorgprofiel. Pas op het moment dat er complicaties als verlies PS of PAV om de hoek komen kijken, komt de patient in aanmerking voor aanvullende voetzorg door de podotherapeut. Voor de volledigheid, men is niet in staat tot zelfmanagement wanneer er sprake is van:
- Cognitieve beperkingen
- Visusklachten
- Alleenstaande risicodrager (bijvoorbeeld alleenstaande ouderen met onvoldoende ziekte inzicht)
- Adipositas
- Bewegingsbeperkingen (stijfheid of overige fysieke beperking)

Beleid 2015 : In 2015 worden patiënten met zorgprofiel 1, 2, 3 of 4 doorverwezen naar een aangesloten podotherapeut.
Bij verwijzing dienen altijd Simms classificatie en zorgprofiel vermeld te worden.